O Imperativo da Dignidade: Uma Análise Abrangente dos Cuidados Paliativos no Oeste de Minas Gerais e a Missão Transformadora do Instituto Sobre'Viver

O panorama da saúde pública no estado de Minas Gerais, e particularmente em sua região Centro-Oeste com epicentro em Divinópolis, atravessa uma conjuntura crítica onde a sofisticação tecnológica dos tratamentos curativos choca-se frontalmente com uma carência histórica na gestão do final da vida. A transição epidemiológica da população brasileira, marcada por um envelhecimento acelerado e uma prevalência crescente de doenças crônico-degenerativas, evidenciou a fragilidade de um sistema desenhado para a agudeza, mas cego diante da terminalidade. Este relatório técnico analisa a profundidade desta crise, as barreiras estruturais e as políticas emergentes, utilizando como eixo central o impacto do Instituto Sobre'Viver na redefinição da dignidade humana em contextos de vulnerabilidade extrema.

A Sombra da Estatística: Um Diagnóstico Desanimador no Centro-Oeste

A magnitude do desafio paliativo em Minas Gerais revela-se através de cifras que, longe de serem meros indicadores, representam um mapa do sofrimento não gerido. Na última década, o município de Divinópolis experimentou um aumento alarmante na mortalidade por neoplasias, refletindo uma tendência nacional que situa o câncer como uma das principais causas de óbito. Entre 2014 e 2023, as mortes por câncer na cidade cresceram 54%, passando de 246 para 379 casos anuais.[1] Este incremento não é um fenômeno isolado da biologia, mas o resultado de uma convergência de fatores que incluem o diagnóstico tardio, o envelhecimento populacional e a persistência de "desertos assistenciais" fora do eixo metropolitano.[1]

O perfil da mortalidade na região Centro-Oeste indica que os tumores de pulmão, cólon e reto, mama, estômago e próstata lideram as estatísticas.[1] O mais preocupante é que 60% a 70% desses diagnósticos ocorrem em pessoas acima de 60 anos, um grupo demográfico que em Divinópolis cresceu de forma consistente, aumentando a pressão sobre uma rede assistencial que já opera no limite de sua capacidade física e operacional.[1]

Indicador de Mortalidade	Dado 2014	Dado 2023	Crescimento (%)

Oncológica em Divinópolis			
Óbitos Totais por Câncer	246	379	54%
Incidência em Maiores de 60 anos	~60%	~70%	10% (incremento líquido)
Gênero com Maior Mortalidade	Masculino	Masculino	N/A

Este cenário agrava-se pelo fato de que a oferta de serviços especializados é inversamente proporcional à necessidade. Em todo o estado de Minas Gerais, existem apenas 71 leitos dedicados formalmente a cuidados paliativos, uma cifra ínfima comparada com os 284 de São Paulo ou os 103 do Rio de Janeiro.[4] Além disso, a concentração desses recursos nas capitais e regiões metropolitanas deixa o interior em um estado de desamparo técnico. O conceito de "desertos assistenciais" materializa-se quando pacientes com dor oncológica refratária ou dispneia terminal precisam viajar centenas de quilômetros para acessar uma consulta especializada ou para o ajuste de uma bomba de infusão de opioides.[3]

A Infraestrutura Hospitalar e o Colapso do Modelo Curativo

O Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), referência para mais de 50 municípios do Centro-Oeste mineiro, exemplifica a luta diária pelo espaço físico. As taxas de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) alcançam frequentemente 100%, enquanto as enfermarias do Sistema Único de Saúde (SUS) superam 60% de sua capacidade total.[5] Esta saturação é alimentada por uma demanda de urgência que absorve 93% das atividades do hospital, deixando uma margem mínima para procedimentos eletivos e, o mais grave, para a atenção paliativa humanizada.[6]

O modelo hospitalocêntrico imperante obriga que a terminalidade seja gerida muitas vezes em ambientes de urgência altamente estressantes. Um paciente em fase terminal pode passar suas últimas horas em uma maca de corredor ou em uma sala de observação compartilhada, rodeado pelo ruído de monitores e o vaivém das emergências, precisamente o contrário do que dita a ética paliativista de conforto e privacidade.[3] Este "descaso do sistema", relatado pelos próprios pacientes que chegam ao Instituto Sobre'Viver, é o sintoma de uma política que prioriza a cura a qualquer custo e marginaliza o cuidado quando a cura já não é possível.[7]

O Labirinto da Judicialização: Entre a Necessidade

Vital e a Sombra da Fraude

Diante da insuficiência do Estado em prover medicamentos de alto custo ou insumos específicos, a justiça tornou-se o principal mediador entre o paciente paliativo e seu direito à dignidade. Este fenômeno, conhecido como judicialização da saúde, fundamenta-se no Artigo 196 da Constituição Federal de 1988.[8] No entanto, o acesso à justiça é um caminho bifurcado em Divinópolis, onde convivem o ativismo legítimo e a corrupção sistemática.

A Judicialização como Escudo: O Papel do Instituto Sobre'Viver

O Instituto Sobre'Viver, através de seu apoio jurídico liderado por profissionais como Camila Santos, transformou o cenário legal para seus pacientes. Nos últimos dois anos, a organização facilitou o bloqueio judicial de R$ 384.000 destinados especificamente a tratamentos, medicamentos e exames para pacientes em estado terminal.[7] Esta ação não é um mero trâmite administrativo; representa a diferença entre uma morte atormentada pela dor física e uma partida em paz.

O suporte jurídico do instituto busca garantir o acesso a fármacos que não estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do SUS, mas que são essenciais para o controle de sintomas complexos. A maioria destas ações judiciais baseia-se no direito à vida e à dignidade humana, superando argumentos de "reserva do possível" ou limitações orçamentárias que a Administração Pública costuma esgrimir.[8] A "microjustiça" — decisões individuais para casos concretos — permite que o paciente receba atenção imediata, embora a longo prazo gere debates sobre a sustentabilidade do sistema público.[10]

O Lado Escuro: A Operação Efeito Colateral

Em agudo contraste com o trabalho do instituto, Divinópolis foi cenário em 2024 de uma das fraudes mais cínicas à saúde pública em Minas Gerais. A Operação "Efeito Colateral", deflagrada pelo Gaeco, desmantelou uma associação criminosa que desviou R$ 656.000 do orçamento estadual de saúde mediante ações judiciais fraudulentas.[11] O grupo, articulado por uma assessora jurídica da própria Vara da Fazenda Pública de Divinópolis, falsificava documentos médicos para simular casos de câncer avançado que exigiriam medicamentos de altíssimo custo.[11]

Impacto Econômico da Gestão Judicial na Saúde (Divinópolis)	**Valor (R$)**	**Situação**
Fraude Detectada (Operação Efeito Colateral)	656.000	Recuperado/Sentenciado

Plano de Fraude Total (Evitado)	1.600.000	Interceptado
Bloqueio Judicial Legítimo (Instituto Sobre'Viver)	384.000	Executado para pacientes
Impacto Social Estimado de Serviços do Instituto	145.000	Investimento Direto

Este caso de corrupção não apenas representa um roubo ao erário, mas mancha a legitimidade de milhares de pacientes que realmente dependem da justiça para sobreviver à sua doença. A existência de tais esquemas de fraude obriga os juízes a serem mais rigorosos, o que muitas vezes atrasa as liminares para quem não tem tempo de esperar. Neste clima de desconfiança, o papel de validação técnica e ética que o Instituto Sobre'Viver oferece torna-se indispensável.[11]

Situações Críticas e Realidades Humanas no Oeste Mineiro

Além dos tribunais e hospitais, a realidade dos cuidados paliativos é vivida no cotidiano das famílias que enfrentam doenças raras e crônicas. A falta de capacitação profissional no manejo da terminalidade é uma das situações mais críticas relatadas na região. Muitos profissionais de saúde, treinados exclusivamente para salvar vidas, veem a morte como um fracasso pessoal e tendem a se afastar do paciente quando os tratamentos curativos cessam.[4]

A escassez de medicamentos é outra constante. Em diversos períodos, a região Centro-Oeste enfrentou dificuldades de acesso a insumos básicos e equipamentos de proteção, situação que se aguçou durante a pandemia, mas que persiste de forma estrutural na gestão de doenças oncológicas.[12] A falta de uma rede de apoio ambulatorial significa que, se um paciente não tem recursos para comprar sua própria medicação, sua única opção é a internação hospitalar, contribuindo novamente para o ciclo de saturação do CSSJD.[6]

Neste contexto, a situação da população pediátrica é especialmente dolorosa. Estima-se que 7% dos pacientes que necessitam de cuidados paliativos no mundo sejam crianças, mas em Minas Gerais a oferta de paliativos pediátricos é quase inexistente fora de Belo Horizonte.[4] Isso obriga famílias de Divinópolis a se deslocarem para a capital para que seus filhos recebam um manejo adequado da dor, rompendo os vínculos sociais e familiares no momento em que mais são necessários.

O Ponto de Inflexão: A História de Laura e a Origem do Sobre'Viver

A transformação da dor individual em uma infraestrutura coletiva é o coração do Instituto Sobre'Viver. Sua fundação não foi resultado de uma política governamental, mas da vivência de Valquíria Santos e sua filha, Laura Vitória, cuja história tornou-se um ícone de resiliência em todo o estado de Minas Gerais.[14]

Uma Batalha de uma Década contra a Neoplasia

Laura Vitória enfrentou três tipos diferentes de câncer ao longo de dez anos, uma odisseia que começou quando tinha apenas 11 anos com um diagnóstico de câncer hepático.[14] Apesar dos protocolos agressivos de quimioterapia e radioterapia, Laura manteve uma atitude de confiança e resiliência que surpreendeu seu entorno médico. No entanto, em 2020, o aparecimento de um glioblastoma multiforme grau 4 — um dos tumores cerebrais mais letais e resistentes ao tratamento — mudou definitivamente o foco de seu cuidado.[14]

A experiência de Valquíria durante os últimos anos de Laura revelou as rachaduras profundas do sistema de saúde. A frieza dos diagnósticos, a falta de opções de conforto e a sensação de abandono institucional quando a cura já não era uma possibilidade médica foram os catalisadores para criar um espaço diferente.[14] O falecimento de Laura aos 19 anos deu vida ao instituto, que opera sob a premissa de que "o amor é mais forte que qualquer dor" e que, enquanto houver um sopro de vida, há espaço para a felicidade e a dignidade.[7]

O Conceito de Comunidade Paliativista

O Instituto Sobre'Viver define-se não apenas como uma clínica, mas como uma "comunidade paliativista". Este conceito, derivado das "comunidades compassivas", busca que o cuidado da pessoa que sofre não seja uma tarefa exclusiva do hospital, mas uma responsabilidade compartilhada pela sociedade.[15] Localizado na Rua Itaguara, 50, no bairro Espírito Santo em Divinópolis, o instituto funciona como um farol de acolhimento para quem o sistema tradicional deixou de ver como sujeitos e começou a tratar como "casos perdidos".[15]

A Operação da Esperança: Serviços e Estratégias do Instituto

Para combater as "cifras desanimadoras" da região, o Instituto Sobre'Viver implementou um modelo de atenção multidisciplinar que aborda as quatro dimensões do sofrimento humano: física, emocional, social e espiritual.[7] Este enfoque é disruptivo em uma região onde a medicina é praticada de forma fragmentada.

Terapias e Suporte Especializado

O portfólio de serviços do instituto é desenhado para maximizar a qualidade de vida através de intervenções que o SUS raramente oferece de forma integrada. A ozonioterapia, por exemplo, é utilizada para o manejo da dor e melhora metabólica, enquanto terapias como o Reiki e a acupuntura buscam o equilíbrio emocional dos pacientes.[7]

- **Ozonioterapia:** Aplicada em ciclos especializados para reduzir a inflamação crônica e melhorar a oxigenação de tecidos em pacientes com mobilidade reduzida.[7]
- **Reiki e Auriculoterapia:** Ferramentas fundamentais para mitigar a ansiedade e a depressão reativa ao diagnóstico terminal.[15]
- **Psicologia Clínica:** Suporte tanto para o paciente quanto para a família, preparando o caminho para o luto e a aceitação.[7]
- **Massoterapia e Fisioterapia:** Focadas na manutenção da funcionalidade e no conforto físico básico.[14]
- **Suporte Jurídico:** Garantia de acesso a direitos básicos e medicação de alto custo.[7]

Impacto Social e Resultados Quantitativos

A eficiência do instituto reflete-se em sua capacidade de absorver a demanda que o sistema público não consegue processar. Em seus dois anos de atividade mais recentes, o impacto social foi massivo para uma organização de base comunitária.

Métricas de Impacto do Instituto Sobre'Viver	**Quantidade / Valor**
Pessoas Atendidas (2 anos)	+370
Pacientes Ativos Mensalmente	21
Impacto Social com Serviços Paliativos	R$ 145.000
Bloqueio Judicial para Tratamentos	R$ 384.000
Alcance do Suporte	Divinópolis e Região

Estes números demonstram que o instituto não apenas oferece consolo espiritual, mas atua como um gestor de recursos críticos. Os R$ 145.000 de impacto social direto representam serviços que, se contratados de forma privada, seriam inalcançáveis para a maioria das famílias da região, e que o Estado simplesmente não provê no formato ambulatorial ou

domiciliar necessário.[7]

O Caso de Mayara e outros Testemunhos de Superação

A narrativa do instituto constrói-se através de casos reais que desafiam a noção de que o paliativismo é sinônimo de rendição. Mayara, uma das pacientes atendidas, compartilhou no início de 2026 uma reflexão sobre o início de um novo ano, mostrando que, mesmo sob a sombra de uma doença grave, é possível projetar desejos e significados.[15] Sua história é utilizada pelo instituto para ressignificar o conceito de "paliativo", que muitas pessoas recebem com medo, mas que o instituto transforma em um "ponto de exclamação" na vida.[15]

Outro testemunho recorrente entre os beneficiários é a queixa sobre o "descaso do sistema de saúde" tradicional. Muitos chegam ao instituto fisicamente debilitados, mas emocionalmente destruídos pela frieza com que foram tratados nos grandes hospitais públicos, onde lhes foi dito que "já não havia nada a fazer".[7] No Sobre'Viver, descobrem que, embora não haja cura para a doença, existem infinitas possibilidades de cuidado para a pessoa.[15]

Políticas Públicas e Novos Horizontes: Minas Gerais 2024-2025

Apesar do panorama inicial desanimador, os últimos anos trouxeram ventos de mudança normativa que poderiam escalar o impacto de iniciativas como a de Valquíria Santos. A Deliberação CIB-SUS/MG Nº 5.090, de fevereiro de 2025, estabelece finalmente as normas gerais para a implementação da Política Continuada de Cuidados Paliativos no estado.[16]

Diretrizes da Nova Política Estadual

Esta normativa é um marco porque reconhece formalmente princípios que o Instituto Sobre'Viver já praticava de forma intuitiva e militante:

1. **Valorização da Vida e Morte Natural:** Reconhece-se a morte como um processo natural, rejeitando a obstinação terapêutica (distanásia) que apenas prolonga o sofrimento.[16]
2. **Multiprofissionalidade:** O cuidado deve ser prestado por equipes interdisciplinares que incluam médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros especialistas.[16]
3. **Regionalização:** Determina-se que cada região de saúde, como o Oeste de Minas, estruture seus próprios serviços para reduzir os deslocamentos e fortalecer a rede local.[16]
4. **Uso de Telessaúde:** O incentivo ao "SUS Digital" permite que especialistas em cuidados paliativos possam dar suporte remoto a médicos da atenção básica em cidades

pequenas, combatendo os desertos assistenciais.[16]

O Papel da Rede de Atenção à Saúde (RAS)

A nova política integra os cuidados paliativos em todos os níveis da rede. A Atenção Primária define-se como a coordenadora do cuidado no território, enquanto o programa "Melhor em Casa" (Atenção Domiciliar) é priorizado como o local ideal para o cuidado paliativo, evitando internações desnecessárias que saturam os hospitais.[4] Os hospitais gerais ficam reservados apenas para o controle de sintomas complexos que não podem ser manejados em casa.[4]

Para garantir a qualidade, o estado estabeleceu requisitos rigorosos para a habilitação de equipes. Os profissionais devem contar com cursos de aperfeiçoamento de pelo menos 180 horas ou especializações de 360 horas em cuidados paliativos.[16] Esta profissionalização da compaixão é fundamental para evitar que o cuidado paliativo seja visto meramente como "caridade" e seja compreendido como uma prática clínica baseada em evidências.

O Protocolo Técnico da Fhemig: Padrões de Conforto

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) publicou em 2024 um guia detalhado de diretrizes assistenciais que complementa o marco legal. Este documento é vital para entender como se está tentando padronizar o conforto nos hospitais públicos do estado. Entre os protocolos técnicos destacam-se:

- **Sedação Paliativa:** Critérios claros para o uso de fármacos que aliviem o sofrimento refratário nos últimos dias de vida, diferenciando claramente entre sedação e eutanásia.[4]
- **Extubação Paliativa:** Protocolos bioéticos para a retirada planejada de ventilação mecânica em pacientes onde o suporte vital tornou-se um fardo desproporcional.[4]
- **Hipodermóclise:** O uso da via subcutânea para a infusão de fluidos e medicamentos, uma técnica menos invasiva e mais confortável que a via intravenosa tradicional, ideal para o ambiente domiciliar.[4]
- **Manejo da Úlcera Terminal de Kennedy:** Guias específicos para o cuidado de feridas em pacientes ao final da vida, reconhecendo a falência dos órgãos como parte do processo de morrer.[4]

Comparativo de Modelos de Atenção em Minas Gerais	**Modelo Tradicional (Saturado)**	**Modelo Sobre'Viver / Nova Política**
Enfoque	Cura ou urgência aguda	Conforto e qualidade de vida
Local do Cuidado	Hospital geral	Domicílio ou Centro de

	(UTI/Corredor)	Acolhimento
Tomada de Decisões	Médica (Paternalista)	Compartilhada (Autonomia do Paciente)
Gestão da Dor	Frequentemente insuficiente	Antecipatória e multidisciplinar
Suporte Familiar	Limitado ou inexistente	Central e contínuo (Incluindo luto)

Desafios de Sustentabilidade e a Economia do Cuidado

O grande desafio para o Instituto Sobre'Viver e para a política estadual é o financiamento. Enquanto o instituto depende de ações solidárias como o "Bazar Beneficente", a "Feijuca" e campanhas de doação via Pix, a política estadual depende de transferências federais que muitas vezes são lentas ou insuficientes.[16] A gestão da judicialização também desempenha um papel econômico: cada real bloqueado judicialmente para um paciente é um real que sai do planejamento orçamentário do estado, o que sublinha a necessidade de que o sistema de saúde seja proativo e não reativo.[10]

O impacto de R$ 145.000 gerado pelo instituto é uma amostra do que a sociedade civil pode alcançar com eficiência. No entanto, para que esta rede se mantenha, é necessária uma integração mais formal com os municípios. Divinópolis, sendo o polo regional, tem a responsabilidade de liderar esta transição, apoiando instituições que já fizeram o trabalho de campo e conhecem as necessidades reais da população.[15]

Conclusões e Recomendações para o Fortalecimento da Rede

A análise detalhada do panorama dos cuidados paliativos no Oeste de Minas Gerais permite concluir que, embora as cifras de mortalidade e o déficit de leitos sejam desanimadores, existe um movimento social e institucional potente para reverter esta realidade. O Instituto Sobre'Viver é a prova viva de que o cuidado humanizado não é um luxo, mas uma necessidade básica que pode ser organizada a partir da própria comunidade.

Ações Recomendadas para os Gestores Públicos

1. **Integração do Terceiro Setor:** O município de Divinópolis deveria estabelecer convênios

formais com instituições como o Sobre'Viver para o encaminhamento de pacientes e o co-financiamento de serviços ambulatoriais de paliativos.

2. **Capacitação Contínua:** Implementar os requisitos da Deliberação 5.090 de forma acelerada, garantindo que todos os médicos e enfermeiros da atenção básica no Centro-Oeste tenham formação básica em paliativos para evitar internações desnecessárias.
3. **Fortalecimento do Suporte Jurídico:** Criar canais de diálogo entre o Poder Judiciário e os especialistas técnicos em saúde para assegurar que as liminares judiciais baseiem-se na melhor evidência paliativista e não apenas na pressão do momento.
4. **Promoção das Diretivas Antecipadas:** Educar a população sobre o direito de registrar suas vontades de tratamento antes de perder a capacidade de decisão, o que é o maior ato de autonomia e prevenção do sofrimento.

O legado de Laura Vitória e o trabalho de Valquíria Santos demonstram que, diante da inevitabilidade da morte, a resposta mais poderosa é a presença ativa e o alívio da dor. O Instituto Sobre'Viver não apenas melhorou as condições de vida de centenas de pessoas em Divinópolis, mas devolveu a esperança a um sistema que frequentemente esquecia sua missão primordial: curar algumas vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre.[7] A transformação de Minas Gerais em um estado paliativista é um caminho longo, mas os alicerces já estão postos na Rua Itaguara, 50, onde a vida, apesar de sua fragilidade, é celebrada em cada gesto de cuidado.

Fuentes citadas

1. Envelhecimento e diagnóstico tardio explicam alta nas mortes por câncer em Divinópolis, avalia oncologista - G1, acceso: febrero 9, 2026, https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2025/11/27/envelhecimento-e-diagnostico-tardio-explicam-alta-nas-mortes-por-cancer-em-divinopolis-avalia-oncologista.ghtml
2. Mortes por câncer crescem 54% em Divinópolis em uma década | G1 - Globo, acceso: febrero 9, 2026, https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2025/11/27/mortes-por-cancer-crescem-54percent-em-divinopolis-em-uma-decada-homens-sao-as-principais-vitimas.ghtml
3. Centro-Oeste de MG dobra o número de cidades onde o câncer é a doença que mais mata, acceso: febrero 9, 2026, https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2025/11/28/centro-oeste-de-mg-dobra-o-numero-de-cidades-onde-o-cancer-e-a-doenca-que-mais-mata.ghtml
4. LINHA DE CUIDADOS E DIRETRIZES ASSISTENCIAIS ... - Fhemig, acceso: febrero 9, 2026, https://www.fhemig.mg.gov.br/files/1394/Protocolos-Clinicos/33307/Linha-de-Cuidado-e-Diretrizes-Assistenciais---Cuidados-Paliativos-%C2%A0(caderno%C2%A0n%C2%BA2).pdf
5. Situação de leitos preocupa autoridades em saúde em Divinópolis; expectativa é

implantação de mais um Hospital de Campanha | G1, acceso: febrero 9, 2026, https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2021/03/16/situacao-de-leitos-preocupa-autoridades-em-saude-em-divinopolis-expectativa-e-implantacao-de-mais-um-hospital-de-campanha.ghtml
6. Comissão de Saúde da Câmara de Divinópolis fiscaliza leitos públicos do Complexo de Saúde São João de Deus | G1, acceso: febrero 9, 2026, https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2021/03/04/comissao-de-saude-da-camara-de-divinopolis-fiscaliza-leitos-publicos-do-complexo-de-saude-sao-joao-de-deus.ghtml
7. contenido_portafolio.txt
8. A fundamentação jurídica da judicialização da saúde de pacientes oncológicos em Belo Horizonte | Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, acceso: febrero 9, 2026, https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/1282/1698
9. O direito à vida e a judicialização da saúde - Civilistica.com, acceso: febrero 9, 2026, https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/download/522/530/1483
10. Entre o conflito e a conciliação: análise da judicialização da saúde em Minas Gerais, acceso: febrero 9, 2026, https://www.scielo.br/j/sdeb/a/CQkLNtBTRFFTKSNvQvQFMJN/?lang=pt
11. Após denúncia do MPMG, Justiça condena grupo que fraudou ação judicial de saúde milionária | Portal, acceso: febrero 9, 2026, https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/apos-denuncia-do-mpmg-justica-condena-grupo-que-fraudou-acao-judicial-de-saude-milionaria.shtml
12. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE, acceso: febrero 9, 2026, https://repositorio.unicamp.br/Busca/Download?codigoArquivo=592697&tipoMidia=0
13. COVID-19: Hospital de Cristais passa a ser referência no atendimento - Estado de Minas, acceso: febrero 9, 2026, https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/04/01/interna_gerais,1252991/covid-19-hospital-de-cristais-passa-a-ser-referencia-no-atendimento.shtml
14. Transformando dor em esperança: após morte de filha, mãe cria ..., acceso: febrero 9, 2026, https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2023/08/13/transformando-dor-em-esperanca-apos-morte-de-filha-mae-cria-instituto-para-cuidados-paliativos-de-pacientes-com-doencas-cronicas-em-mg.ghtml
15. Instituto Sobre Viver (@institutosobreviver37) • Instagram photos ..., acceso: febrero 9, 2026, https://www.instagram.com/institutosobreviver37/
16. 1 DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 5.090, DE 06 DE ... - COSEMS/MG, acceso: febrero 9, 2026, https://api.cosemsmg.org.br/image/notice_1739367943452.pdf